

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS. Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Pemasangan IUD adalah memasukkan alat atau benda ke dalam rahim untuk mencegah terjadi kehamilan.	
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah- langkah dalam melakukan pemasangan IUD.	
Kebijakan	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,keluarga berencana dan sistem informasi keluarga 2. PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 3. PERMENKES RI No. 514 Tahun 2015 tentang managemen pelayanan KB	
Prosedur	1. Alat dan bahan 1) spekulum vagina 2) tenakulum 3) sonde uterus 4) korentang/ conam ovum 5) gunting 6) kom kecil 7) bak instrumen 8) handschoon 9) betadin 10) kassa steril 11) tempat sampah kering dan basah 2. Langkah-langkah 1) petugas menyambut pasien dengan ramah 2) petugas melakukan anamnesa 3) petugas mengisi kunjungan 4) petugas menimbang BB dan mengukur tekanan darah 5) petugas memberikan konseling untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan untuk menggunakan AKDR 6) petugas menjelaskan proses pemasangan IUD kepada klien 7) petugas melakukan USG untuk melihat ada atau tidaknya kelainan Rahim. 8) petugas memastikan pasien sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genetalia dengan menggunakan sabun dan air 9) Petugas membantu pasien untuk naik ke tempat pemeriksaan 10) Petugas mencuci tangan dan memakai handscoon 11) Petugas melakukan palpasi daerah perut dan memeriksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainnya daerah supra pubik 12) Petugas menggunakan kain penutup pada klien pemeriksaan panggul 13) Petugas mengatur cahaya untuk melihat serviks 14) Petugas menempatkan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam wadah steril atau bak instrumen 15) Petugas memakai inspeksi pada genetalia eksternal	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN IUD		
	No.Dokumen 537.4/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 1
	16) Petugas melakukan spekulum vagina 17) Petugas melakukan pemeriksaan inspekulo, pemeriksaan adanya lesi atau keputihan pada vagina dan inspeksi serviks 18) Petugas memasang speculum vagina untuk melihat serviks 19) Petugas mengusap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali 20) Petugas memasukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh (no touch technique) yaitu tanpa menyentuh dinding vagina atau bibir spekulum 21) Petugas menentukan posisi dan kedalaman kavum uterus dan mengeluarkan sonde 22) Petugas mengukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter yang masih berada didalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. 23) Petugas memasang serta tahan tenakulum dan mendorong satu tangan 24) Petugas melepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik with drawel yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong 25) Petugas mengeluarkan pendorong, kemudian tabung inserter di dorong kembali ke serviks sampai ke leher biru menyentuh 26) Petugas mengeluarkan seluruh tabung inserter dan buang ke tempat sampah terkontaminasi 27) Petugas mengeluarkan speculum dengan hati-hati 28) Petugas membuang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi (kasa, sarung tangan) ketempatnya. 29) Petugas memastikan posisi IUD dengan melakukan USG dan memastikan pasien tidak mengalami kram hebat dan amati selama 15 menit sebelum memperoleh pulang 30) Petugas mengajarkan pasien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus kembali untuk control 31) Petugas menjelaskan pada pasien agar segera kembali ke fasilitas kesehatan bila mengalami efek samping 32) Petugas mengingatkan kembali masa pemakaian AKDR Copper T adalah 8 tahun dan nova T adalah 5 tahun 33) Petugas melepaskan handscoon dan mencuci tangan		
Unit Terkait	1. Poli Kandungan 2. Poli KIA		